

Uretroplastia endoscópica (TUITMR)

WARWIKI

Información para el paciente · Reparación sin corte de una cicatriz en el cuello de la vejiga

Es la reparación de una cicatriz apretada en el cuello de la vejiga, o donde se reconectó la vejiga tras una cirugía de próstata, hecha por completo con un endoscopio — sin corte externo. Su cirujano abre la cicatriz y luego cose mucosa sana de la vejiga sobre ella, para que la zona sane abierta en vez de volver a cerrarse.

Acerca de este procedimiento

Tras una cirugía o radiación de próstata, puede formarse una cicatriz apretada en el **cuello de la vejiga**, o en la unión entre la vejiga y la uretra, y bloquear el chorro de orina. Solo cortar la cicatriz suele dejar que se cierre otra vez, porque sana sobre tejido cicatricial crudo.

Esta técnica — **TUITMR** (incisión transuretral con realineación mucosa transversa) — resuelve ese problema:

- El cirujano **corta la cicatriz** con un endoscopio para abrir el canal.
- Luego, con una **herramienta de sutura** especial, se trae mucosa sana de la vejiga y se cose sobre el corte — como un colgajo, pero a través de la uretra.

Los primeros resultados son alentadores: cerca de **9 de cada 10** siguen abiertos tras un procedimiento, y casi todos tras un segundo — con muy poco riesgo de nuevo escape en el primer grupo reportado.

¿Es seguro?

Se hace por completo a través de la uretra, evitando las cirugías robóticas o abiertas más grandes que se usan para este problema. La evidencia inicial es prometedora, incluido un bajo riesgo de nuevo escape de orina, que puede complicar otras reparaciones aquí. Los riesgos incluyen sangrado, infección urinaria y que la estrechez vuelva. Es una técnica más nueva y especializada.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Cuello de la vejiga

La salida donde la vejiga desemboca en la uretra.

Contractura del cuello de la vejiga

Cicatriz apretada en el cuello de la vejiga que bloquea el chorro.

Estenosis anastomótica

Estrechez por cicatriz donde se reconectó la vejiga tras la cirugía de próstata.

Uretra

El tubo que lleva la orina fuera del cuerpo.

Mucosa (revestimiento)

El revestimiento interno sano que se avanza sobre la cicatriz para sanarla abierta.

Cistoscopia

La cámara delgada con la que trabaja el cirujano.

Incontinencia

Escape de orina — un riesgo que esta técnica busca mantener bajo.

Sonda

Tubo blando que se deja en la uretra un tiempo corto mientras sana.

¿LE DOLERÁ? El procedimiento se hace bajo anestesia, así que no siente nada durante él. Después, espere ardor leve y algo de orina con sangre por unos días. Se deja una sonda un tiempo corto. La mayoría va a casa el mismo día o tras una estancia breve.

Cómo prepararse (antes del procedimiento)

- Se hace bajo **anestesia general** — siga todas las instrucciones de cirugía (ayuno y qué medicinas suspender, incluidos los anticoagulantes).
- Un **análisis de orina** revisa si hay infección — una infección debe tratarse primero.
- Cuente con una **sonda por un tiempo corto** y organice quién lo lleve a casa.

Avise a su equipo con tiempo si:

- Toma un **anticoagulante** o tiene una infección urinaria actual
- Ha tenido **cirugía de próstata, radiación** u otros tratamientos en esta zona

Qué sucede durante el procedimiento

- 1 Está dormido bajo anestesia y se administran antibióticos.
- 2 Se pasa un endoscopio hasta la cicatriz y se coloca una guía por seguridad.
- 3 Se ensancha y se corta la cicatriz para abrir el canal.
- 4 Con una herramienta de sutura pasada por la uretra, se avanza mucosa sana de la vejiga y se cose sobre el corte, y se deja una sonda.

Después del procedimiento

- Va a casa el **mismo día o tras una estancia breve**, con una sonda por un tiempo corto.
- Espere **ardor leve y orina rosada** por unos días. Beber agua extra ayuda.
- **Evite levantar peso y esfuerzos** por unas semanas.
- Una revisión con endoscopio (hacia los **4 meses**) confirma que la zona sigue abierta.

Llame a su equipo o busque atención si tiene:

- Fiebre o escalofríos
- **No puede orinar**, sobre todo al retirar la sonda
- Nuevo **escape** abundante de orina
- Sangrado abundante, coágulos o dolor que empeora

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Es una reparación sin corte de una cicatriz en el cuello de la vejiga — se abre la cicatriz y se cubre con mucosa sana para que sane abierta, con bajo riesgo de nuevo escape.
2. Para prepararse: siga las instrucciones de ayuno y medicinas, trate primero cualquier infección, cuente con una sonda un tiempo corto y organice quién lo lleve.
3. Ardor leve y un poco de orina rosada por unos días es normal, y un endoscopio de control confirma el éxito. Llame de inmediato si tiene fiebre, no puede orinar, nuevo escape abundante o sangrado fuerte.